2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

APRENDIZADOS SOBRE A REALIDADE AMAZÔNICA DE UMA FACILITADORA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE VÍNCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Lais Gomes De Oliveira – Mestranda PROFSAÚDE - Universidade Federal de Alagoas – UFAL e Médica de Família e Comunidade
Maria das Graças Monte Mello Taveira – Universidade Federal de Alagoas

Figura 1 – UBS fluvial na cidade de Carauari-AM, às margens do rio Juruá, 2025 (acervo pessoal)

A experiência como facilitadora evidenciou que a prática da Medicina de Família e Comunidade na Amazônia se constrói em cenários de extrema complexidade, marcados por barreiras geográficas, vulnerabilidades sociais e limitações estruturais. Ainda assim, revelou-se a potência das equipes em produzir cuidado longitudinal, territorializado e culturalmente sensível. A sistematização das experiências mostrou-se ferramenta fundamental para dar visibilidade às iniquidades regionais e tensionar o debate nacional sobre equidade no SUS.

Introdução

A Amazônia brasileira permanece, historicamente, marcada por invisibilidades estruturais que repercutem diretamente na organização do cuidado em saúde. As especificidades territoriais — como grandes distâncias, acesso predominantemente fluvial, diversidade sociocultural e presença de populações tradicionais — impõem desafios singulares à Atenção Primária à Saúde (APS).

Nesse contexto, o Programa Mais Médicos e os processos formativos a ele vinculados assumem papel estratégico na qualificação do cuidado, ao mesmo tempo em que expõem desigualdades persistentes entre regiões do país. A vivência como facilitadora em um curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade voltado para médicos atuantes na Amazônia possibilita uma aproximação crítica com essas realidades, ampliando o olhar sobre o SUS para além dos contextos urbanos e mais estruturados.

Figura 2 – Atendimento domiciliar em comunidades ribeirinhas em Carauari-AL (acervo pessoal)

Objetivos

Relatar a experiência de uma facilitadora do curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade vinculado ao Programa Mais Médicos, destacando as reflexões produzidas a partir das vivências, narrativas e produções acadêmicas dos médicos atuantes na região amazônica.

Métodos

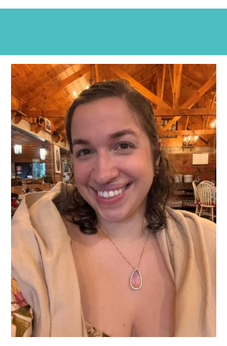
Trata-se de um relato de experiência fundamentado na análise qualitativa das produções acadêmicas desenvolvidas pelos médicos em formação, bem como nas discussões realizadas durante encontros síncronos do curso. A análise buscou identificar temas recorrentes relacionados ao processo de trabalho, organização do cuidado e desafios enfrentados, além das estratégias construídas para garantir acesso e continuidade da atenção. A vivência como facilitadora permitiu, ainda, a incorporação de uma dimensão reflexiva sobre o próprio processo formativo e suas implicações na construção do conhecimento em saúde.

Resultados

As produções analisadas evidenciam que o cuidado em saúde na Amazônia é fortemente influenciado por determinantes sociais, geográficos e culturais, configurando um cenário de alta complexidade para a Atenção Primária. Destacam-se as barreiras de acesso relacionadas às longas distâncias, dependência de transporte fluvial, escassez de recursos e dificuldades na regulação, comprometendo a continuidade do cuidado. Somam-se a isso vulnerabilidades sociais importantes, como insegurança alimentar e condições habitacionais precárias, além da necessidade de adaptação das práticas às especificidades culturais de populações indígenas e ribeirinhas. Apesar dos desafios, emergem potências no processo de trabalho, como o fortalecimento do vínculo com a comunidade, a valorização do cuidado longitudinal, o uso criativo de tecnologias leves e a integração de saberes locais. A experiência formativa mostrou-se um espaço relevante de troca e reflexão, contribuindo para a ressignificação das práticas e para a ampliação do olhar crítico sobre as desigualdades regionais. Para a facilitadora, esse processo implicou uma ampliação do olhar crítico sobre as desigualdades regionais, bem como uma reflexão sobre os limites das normativas e diretrizes quando confrontadas com realidades tão diversas e desafiadoras.

Conclusão/Considerações finais

Conclui-se que a formação vinculada ao território amazônico não apenas qualifica profissionais, mas também provoca deslocamentos importantes na compreensão do cuidado em saúde no Brasil. A experiência evidencia a necessidade de reconhecer as singularidades regionais na formulação de políticas públicas, evitando a reprodução de modelos homogêneos que desconsideram as especificidades locais. Além disso, reforça a importância de dar visibilidade às experiências produzidas nesses territórios, como forma de tensionar desigualdades históricas e fortalecer o SUS enquanto sistema equânime. Por fim, destaca-se que a aproximação com a realidade amazônica convoca profissionais de outras regiões a reverem suas práticas e ampliarem seu compromisso ético-político com a defesa de um cuidado integral, humanizado e socialmente comprometido.



Lais Gomes de Oliveira
Mestranda PROFSAÚDE – Universidade Federal de Alagoas – UFAL e Médica de Família e Comunidade
E-mail: lais.gomes.oliveira13@gmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PROFSAÚDE
MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA